KRONOSMEDICINE · TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Displasia del desarrollo de la cadera (DDC) de un vistazo

1 ¿Qué es?

Acetábulo poco profundo y cabeza femoral mal centrada.
Va de la displasia sola a la subluxación y la luxación completa.

Luxada · **Luxable** · **Subluxable**

Forma teratológica: rígida, irreductible, neuromuscular.

2 Epidemiología

2–5
por cada 1,000 nacidos vivos

♀
Más en niñas

Lado afectado

Izquierda	
Bilateral	
Derecha	

3 Factores de riesgo

- Sexo femenino
- Primer embarazo
- Presentación pélvica
- Antecedente familiar
- Oligohidramnios
- Envolver con piernas en extensión

4 Clínica por edad

0 a 3 meses

Barlow → sale
aducción + presión posterior

Ortolani → entra
abducción + trocánter arriba

El "click" es inocente;
el "clunk" es patológico.

3 a 12 meses

Limitación de abducción
el signo más útil

Galeazzi y pistón

Pliegues asimétricos

Acortamiento del muslo

Al caminar

Trendelenburg
la pelvis cae al lado sano

Marcha de Duchenne

Bilateral: hiperlordosis y marcha de pato

5 Estudios de imagen

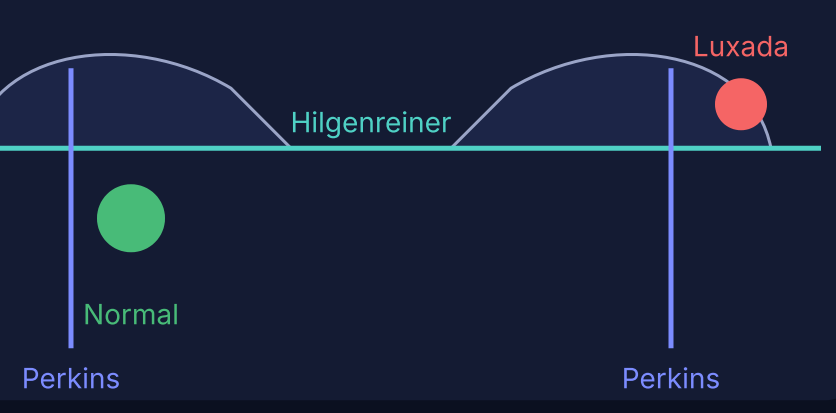
Menos de 4 meses

Ultrasonido
La cabeza aún no se osifica.

4 meses o más

Rx AP de pelvis ± Von Rosen
Índice acetabular normal < 30° al nacer.
Tríada de Putti desde los 6 meses.

Líneas en la radiografía
Normal: cuadrante inferomedial.



6 Tratamiento según la edad

Menos de 6 meses
Arnés de Pavlik
Si no reduce en 3–4 semanas, suspender y referir.

6 a 18 meses
Reducción cerrada
Tenotomía, artrografía y yeso pelvipodálico.

Más de 18 meses
Reducción abierta
± osteotomías pélvicas o femorales.

Pavlik contraindicado en mielomeningocele, artrogriposis, Ehlers-Danlos y forma teratológica.

Toda sospecha se refiere a segundo nivel. Mejor pronóstico si se trata antes de los 4 meses.